

Imc 25,76

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 22231696641 / 913

CLOVIS MASARU KOBAYASHI

IDADE: PESO: 78 ALTURA: 174 PROFISSÃO: Engenheiro

SINTOMAS:

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS:

MÉDICO: Dr. Cláudio Ed. / Dr. Patrícia

MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N

EXERCÍCIO FÍSICO:

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: HORA QUE ACORDA:
COCHILLO () SIM () NÃO DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO:

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: N MALLAMPATI: IV IAH: 51.4 SPO2: 77%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS

06/03 Avaliação e adaptação do CPAP.
24 P=4-13 cmH₂O - Automático

18/03 P=8,0 cmH₂O

24 IAH=0,8 e/ev

m. de uso: 5h40'

Bem adaptado, s/ queixas

lua

25/03/24 P=8 cmH₂O

IAH=1,8 e/ev

m. de uso: 6h 19m

Bem adaptado

Natasha

08/04/24 P=8 cmH₂O

IAH=1,9 cmH₂O

m. de uso: 5h41m

Bem adaptado / Oriente higienização

Natasha

10/03 P=7,6 cmH₂O

IAH=0,6 e/ev

m. de uso: 5h30'

Bem adapt. sem queixas

Oriento higiene dos sons (horário de dormir).

lua

06/05 P=8 cmH₂O

24 IAH=1,0 e/h

m. de uso: 5h Bem adaptado

fuga P₉₅: 9,2 Queixa de aerofagia

Oriento elevação cabeceira da cama

Natasha

13/06/24 P=8 cmH₂O

IAH=0,6 e/h

Bem adaptado

m de uso: 5h5m

fuga: 6,7 l/min (percentil) Natasha

27/08/24 P=8 cmH₂O

IAH=0,5 e/h

m de uso: 5h 24'

fuga: 5,7 l/m

Usou por 1 semana e não levou o cpg por isso a medição caiu.

Natasha

29/10/24 P=8 cmH₂O

IAH=0,9 e/h

m de uso: 5h 28'

fuga: 5,8 l/m

Bem adaptado

Siqueros

Natasha

07/01/2025 P=8,0 cmH₂O

IAH=0,6 e/h

m uso= 5h 46 min

fuga: 5 l/min

Bem adaptado.

queixa Aerofagia

Silene

↓ P: 7,6 cmH₂O.

09/06/25 P=7,6 cmH₂O

IAH=0,7 e/h

m uso= 6h 12 min

fuga: 12 l/min

sem queixas; bem adaptado.

Silene

Nome: CLOVIS MASARU KOBAYASHI

Data de Nascimento: 1-11-1962

IMC: 25,76

Sexo: Masculino

Data do exame: 11-06-2022

Peso: 78 kg

Altura: 1,74 m

Médico: DR. CLAUDIO F. JARDINI

Medicamentos:

Histórico:

Lauda de Polissonografia

Exame realizado na noite de 11-06-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 556,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 133,5 e 146,0 minutos. O tempo total de sono foi de 329,5, eficiência de 59,3% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,8%; estágio N2: 60,8%; estágio N3: 17,8%; sono REM: 19,6%. O índice de despertares foi de 22,3/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 51,4/hora, sendo elas 44 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 170 hipopnéias. A SpO2 média foi de 89% e mínima de 77%, permanecendo 21,7% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 55 - 82 bpm e NREM de 58 - 82 bpm.

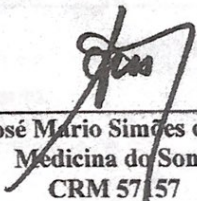
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (8), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 51,4/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=77%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157